内科含诊断 + 外科 胸膜疾病 ★★★（1~5 题）

胸腔积液

（内 2011、2020、2025）

	栗子	比重	蛋白	细胞计数	葡萄糖
渗出性胸水	感染、肿瘤、风湿→通透性↑	＞ 1.018	＞ 30、李凡他试验 (+)	＞ 500×10^6	＜ 3.3
漏出性胸水	右心衰、心包积液、缩窄性心包炎→静水压 / 血压↑ 肝硬化、肾病、透析→血浆胶渗压↓ 药物过敏→通透性↑ “我的心肝肾快吃药”	＜ 1.018	＜ 30、李凡他试验 (-)	＜ 100×10^6	与血糖相近

（内 2007、2008、2009、2011、2015、2017、2021、2022、2026）

	ADA	CEA	LDH	主要细胞	其他	治疗
结核	＞ 45	＜	＞ 200	单个核细胞（淋巴细胞）	多低热、可有血性胸水	尽快抽净胸水 不向胸膜腔给抗结核药
肺癌	＜ 45	＞	＞ 500	单个核细胞（淋巴细胞）	中老年多见 多不发热或低热、可有血性胸水	化学性胸膜固定术 （胸膜腔给抗肿瘤药、滑石粉）
急性脓胸	＞ 45	＜	＞ 500	多个核细胞（中性粒细胞）	多寒战高热 胸水细胞可＞ 10×10^9、pH 可 <7	需向胸膜腔给抗生素 最基本：引流

检查



诊断胸腔积液首选：X 线
- 肋膈角变钝
- 外高内低弧形致密影
- D 字型的包裹性积液

- 定位准确可引导穿刺：B 超（2023）
- CT：可提示积液性质
- 明确积液性质（病因诊断）
  - 胸腔穿刺（内 2007、2011、2021，外 2023）
  - 高度怀疑恶性胸水：胸腔镜最佳（内 2009）

抽液：首次＜ 800、以后＜ 1000

- 抽液过快过多→复张后肺水肿（内 2012）
  - 咳大量泡沫痰、双肺满布湿啰音
  - 停抽、吸氧、限液
- 刺激迷走神经→胸膜反应
  - 血压↓、头晕、心悸、出汗
  - 停抽、监测血压防休克（必要时给肾上腺素）